

倫理的権利から制度的保障へ

— 日本の病院面会と診療報酬ガバナンス —

From Ethical Entitlement to Institutional Protection:
Hospital Visitation and Reimbursement Governance in Japan

George Kujo / Kazuya Iwai / Shunsuke Takagi

Zenodo公開日本語版 v0.1 (2026年10月6日)

正式版(英語): *From Ethical Entitlement to Institutional Protection: Hospital Visitation and Reimbursement Governance in Japan*

SSRN DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.7558618>

SSRN掲載ページ: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=7558618

Zenodo DOI: [10.5281/zenodo.23186926](https://doi.org/10.5281/zenodo.23186926)

注: 本稿はSSRNで公開された英語版の日本語版である。学術的引用および版管理上の正式版は英語版とし、日本語版は日本語読者の利便のために公開する。日本語版と英語版の間に解釈上の差異が生じる場合は、英語版を優先する。

要旨

日本では、新型コロナウイルス感染症の急性期を過ぎた後も病院の面会制限が確認されていた。2026年度診療報酬改定は、病院面会に関する全国的な規律を導入した。本稿はこれを単なる支払政策ではなく、倫理的に認識された患者利益を、緊急時に施設裁量が拡大しても利用可能な制度的保障へ変換する試みとして分析する。患者には、自ら選ぶ人との関係的アクセスについて、尊厳、関係的自律、与益、無危害に基づく推定的な倫理的権原があると論じる。制限は正当化され得るが、必要性、比例性、個別化、時間的限定、再検討可能性を要する。改定は、広く適用される推奨的規定と、特定の入退院支援加算に結び付きより強い要件からなる二層構造を形成する。全国では7,949病院中4,358病院(54.8%)が少なくとも一つの対象加算を届け出ている。これは制度的カバレッジであり、実際の面会や権利の実効性を示すものではない。また、診療報酬だけでは普遍的な患者向け最低保障にならない理由を示している。既存の比例性と継続の見直しの倫理指針を、制限が長期化するほど継続には新たな正当化が必要になるという「時間的な正当化負担」へ展開する。日本の精神保健法制と国外の患者権利法制は、施設権限と患者向け保障が両立し得ることを示す。本稿は、倫理的権原、患者向け手続、監督、必要に応じた法的・行政的バックストップ、診療報酬による実装支援からなる多層モデルを提案する。

キーワード: 病院面会; 患者の権利; 関係的自律; 制度的保障; 診療報酬; 生命倫理

1. はじめに

日本では、2023年5月に新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行した後の2024年にも、病院の面会制限が確認されていた(Ministry of Health, Labour and Welfare n.d.; Ministry of Health, Labour and Welfare 2025)。厚生労働省の2024年度調査では、回答した2,790施設の61.5%が面会者の年齢を制限し、58.8%が患者1人・1日当たりの面会人数を制限していた(Ministry of Health, Labour and Welfare 2025)。

病院面会は、まず診療報酬や法令によって作られるものとして理解すべきではない。重要な他者との関係を維持したい患者にとって、関係的アクセスは、尊厳、関係的自律、意思決定、与益、無危害に関わる。これは無制限ではなく、感染対策、他の患者の権利と安全、個別の臨床状況によって制限が正当化されることはある。倫理的な問いは、何が制限を正当化するのか、そして制限が行われている間も患者利益をどのように保障するのかである。

既存の生命倫理学文献はすでに、公衆衛生緊急時の面会・支援者同席について、比例性、害の軽減、透明な方針形成、個別例外、強い推定を支持している(McDougall et al. 2023; Dugdale et al. 2023)。したがって本稿の貢献は、「面会制限には比例性が必要である」と繰り返すことではない。

未解決なのは制度の問題である。倫理的に認識されていても、争いのある個別事例で、患者が理由を受け取り、例外を求め、いつ制限が再検討されるかを知り、reviewを求められるとは限らない。問題は、倫理的承認と、持続的で患者が実際に利用できる制度的保障との間のギャップである。

日本はこの問題を検討する上で有用な事例を提供する。こうした背景のもと、2026年6月の診療報酬改定は、全国的な面会規律を明示的に導入する重要な制度的前進であり、より強い加算固有規定は、面会を患者の尊厳の保持と療養生活の質の向上に明示的に結び付けている (Ministry of Health, Labour and Welfare 2026a)。

改定には二つの層がある。広く適用される一般規定は、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げないよう、規定を設けるなどの配慮をすることを「望ましい」とする。これに対し、特定の入退院支援加算を届け出る病院には、正当な理由なく面会を妨げてはならないこと、やむを得ない制限を必要以上に厳格にしないこと、書面の規定、定期的見直し、見やすい場所への掲示・周知という、より強い要件が課される (Ministry of Health, Labour and Welfare 2026a)。全国では7,949病院中4,358病院 (54.8%) が少なくとも一つの対象加算を届け出ている。

この区別が重要なのは、診療報酬に結び付く義務と患者向け保障は、制度上異なる関係だからである。日本では患者の権利が長く倫理的・専門的議論の対象となってきた (Morikawa 1994)。それにもかかわらずCOVID-19期に長期かつ包括的な制限が成立し、その後全国的制度対応が必要になったことは、倫理的承認が、施設裁量の拡大時にも利用できる手続、review、監督、法的・行政的バックストップへ自動的に変換されるわけではないことを示唆する。

本稿は三つの主張を提示する。第一に、患者には、自ら選ぶ人との関係的アクセスについて推定的な倫理的権原があり、制限には必要性、比例性、個別化、時間的限定、再検討可能性が求められる。第二に、2026年改定は重要な前進だが、診療報酬に結び付く要件は患者向け保障と同一ではない。第三に、日本の事例は、倫理的承認が実在しても危機時に利用可能な持続的保障へ十分に制度化されない「承認—制度化ギャップ」を示している。

2. 方法と資料

本稿は、規範的制度分析、法令・政策文書分析、限定的な機能比較、ならびに特定の診療報酬要件の制度的カバレッジに関する記述分析を用いる。新たな人対象データは収集していない。

日本の資料には、2026年度診療報酬資料、精神保健福祉法と精神科処遇基準、精神医療審査会資料、医療安全支援センターの制度枠組みを含む (Ministry of Health, Labour and Welfare 2026a; Ministry of Health, Labour and Welfare 1988; Japan 1950; Ministry of Health, Labour and Welfare 2026b; Japan 1948; Ministry of Health, Labour and Welfare 2023)。比較対象には、42 C.F.R. §482.13、クロアチア患者権利保護法、ハンガリー保健法 Act CLIV of 1997 を用いる (United States 2026; Republic of Croatia 2004; Hungary 1997)。

比較は機能的なものであり、法的同等性を主張するものではない。規範の名宛人、アクセスの原則、許容される制限、理由提示とreview・grievanceの経路、執行を比較する。法体系と規制目的の違いにより、制度移植には限界がある。

規範分析は、倫理的なvisitor policy、緊急時のcaregiver presence、関係的自律、制限の方針の不確実な利益と報告されている害に関する文献に依拠する (Høeg, Knudsen, and Prasad 2025; World Medical Association 2023; Iness et al. 2022; McDougall et al. 2023; Dugdale et al. 2023; Morikawa 1994; Asagumo 2022)。HohfeldとFeinbergは補助的な概念資源としてのみ用いる (Hohfeld 1913; Feinberg 1970)。本稿はHohfeldから倫理的権原を導かず、日本法上の面会請求の根拠となり得るすべての法源を網羅的に確定するものでもない。

制度的カバレッジについては、全国の7地方厚生局と四国厚生支局が公表する施設基準届出受理状況の公式名簿を、2026年7月1日または8月1日現在のスナップショットで確認した (Regional Bureaus of Health and Welfare 2026)。各アクセスページ、分析に使用したスナップショット日、分母資料はOnline Resource 1に記載した。精神科入退院支援加算を除き、入退院支援加算1～3のいずれかを届け出た病院を抽出した。下位区分を常に確実に識別できるわけではないため、主指標は「いずれかの届出あり」の二値とした。

分母には、厚生労働省「医療施設動態調査」2026年5月末概数の7,949病院を用いた (Ministry of Health, Labour and Welfare 2026c)。5県では資料中の施設種別変数を用い、それ以外では20床以上を病院として分類

した。導出分類データセットの病院総数は7,955であり、47都道府県中46都道府県で公式病院数との差は2%未満だった。そのため病床規模別分母の合計は7,949ではなく7,955となる。病床規模別割合はこの導出分類データセット内の記述値であり、公式全国分母に代わるものではない。7地方厚生局と四国厚生支局にまたがる40病院を手作業で再確認したところ、医療機関番号、住所、病床数、加算届出のすべてで一致した。

3. 日本の二層型診療報酬アーキテクチャ

3.1 広く適用されるが推奨的な一般規定

2026年改定は、全国的な入院医療の枠組みの中に面会を位置づけた。広く適用される一般規定は、家族等による面会について、感染対策等の正当な理由なく妨げないよう、面会に係る規定を策定するなどの配慮することを「望ましい」としている(Ministry of Health, Labour and Welfare 2026a)。これにより、面会は病院ごとの慣行や厚意だけではなく、病院行動に関する全国的な期待として明示された。

ただし、この規定の規範的強度には限界がある。日本語原文は推奨的な「望ましい」を用いている。争いのある個別事例で、患者が面会を求め、拒否理由を受け取り、迅速な再検討を開始させる手続を明示してはいない。したがって、施設行動に関する重要な全国的期待を設定する一方、完全な患者向け手続アーキテクチャを定めたものではない。

3.2 より強い加算固有要件

入退院支援加算1～3には、より強い規定が適用される(Ministry of Health, Labour and Welfare 2026a)。病院は、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げてはならず、やむを得ない制限についても必要以上に厳格にならないよう配慮しなければならない。書面の規定、定期的な見直し、周知も要求される。

この層は、より強い禁止的文言を用い、特定の診療報酬構造に付随する条件として機能する。施設基準は、届出、支払い、行政上の調査・指導を通じて病院行動に影響し得る。非遵守は算定資格や返還に関係する可能性があるが、個別の面会拒否一件がそのような結果を直ちに生じさせるかは不明であり、個別事例での実際の執行は本稿では検証しない。診療報酬は強力な政策手段だが、患者個人の救済手続として機能するわけではない。

また、加算を算定しないことが、すべての面会関連義務を消滅させるわけではない。一般規定や他の倫理的・法的義務は残る。しかし、最も強い診療報酬固有の層は、全病院に共通する制度的最低保障ではない。すべての入院患者に共通する最低保障は、算定状況から独立した倫理的根拠と、必要に応じて法的・行政的根拠に置き、診療報酬はその遵守を支援すべきである。

3.3 全国カバレッジ

全国47都道府県では、7,949病院中4,358病院が少なくとも一つの対象加算を届け出ており、全国カバレッジは54.8%だった(Regional Bureaus of Health and Welfare 2026; Ministry of Health, Labour and Welfare 2026c)。都道府県別では香川県の40.5%から奈良県の69.9%まで幅があった。

病床規模別では、20～99床39.5%(1,122/2,838)、100～199床61.2%(1,701/2,779)、200～399床58.4%(961/1,645)、400床以上82.8%(574/693)だった。中間規模群では単調増加ではなかった。

届出は、実際の面会、遵守、例外運用、実効的権利の代理指標ではなく、病床規模差を因果的に解釈することもできない。対象加算には所定の看護職・社会福祉職配置要件が含まれるため、資源の利用可能性が規模差に寄与している可能性はあるが、病院レベルの人員配置は測定していない。

54.8%という数値が示すのは、より強い加算固有規制層の病院レベルの到達範囲である。その意味は「非普遍性」にあり、その層にさらされる患者割合の推計ではない。したがってこれは、診療報酬だけで普遍的な患者向け最低保障を確保することの構造的限界を示す。診療報酬は強力な実装レバーであるが、基礎となる患者利益が算定状況にかかわらず成立すると考えるなら、支払い制度がその利益の存在や範囲を決めることはできない。

4. 倫理的権原と診療報酬の限界

本稿は、患者には、自ら選ぶ人との関係的アクセスについて推定的な倫理的権原 (presumptive ethical entitlement) があると論じる。これは、支援者同席・面会の機会を強く推定し、自律を関係的なものとして捉え、制限的なvisitor policyに比例性、害の考慮、個別例外、継続的再評価を求める既存研究を、本稿が規範的に統合したものである (McDougall et al. 2023; Dugdale et al. 2023; Asagumo 2022)。この権原は、診療報酬上の地位や法令による創設ではなく、尊厳、関係的自律、与益、無危害に基づく。問題となるのは、患者自身にとって重要な関係を維持する利益であり、家族一般が持つ権利でも、訪問者の無制限な立入り権でもない。

ここでいう倫理的権原とは、反証可能な倫理的請求であり、正当化のデフォルトを定める。関係的アクセスを望む患者が、まず特別な臨床利益を証明しなければならないのではなく、アクセスを制限する施設側が正当化負担を負う。この用語は、それ自体として既に法的に執行可能な権利が存在することを意味しない。

この権原は推定的であり絶対的ではない。感染リスク、他の患者の権利、臨床状況、患者自身の希望によって制限が正当化されることはある。最低限の制度的内容は、①患者が選ぶ人とのアクセスを原則とすること、②制限に必要性和比例性を求めること、③一律ルールだけでなく個別化と例外を可能にすること、④時間的限定と再検討可能性を確保すること、の四つである (World Medical Association 2023; McDougall et al. 2023; Dugdale et al. 2023)。

関係的アクセスには直接的な臨床的意義もあり得る。認知症、意識障害、せん妄リスク、重大な意思疎通困難がある患者では、家族や支援者が、通常時の認知・行動、生活歴、選好、価値観に関する情報を提供し、臨床評価や支援付き意思決定に役立つ場合がある (Dugdale et al. 2023)。ただし家族の存在が常に不可欠または有益とは限らない。重要な人物は親族とは限らず、家族が常に患者利益を代表するわけでもない。したがって誰を受け入れ、誰を拒否するかを中心に患者本人が置かれなければならない。

最終的な対話、急変時の同席、緊急の意思決定支援など、時間に依存し後から回復できない損失もある。これはアクセスを絶対化するものではないが、正当化要求を強める。

Hohfeldの分析はここでは限定的に用いる。一人が法的claim-rightを持つ場合、それは他者の法的義務と関連する (Hohfeld 1913)。本稿はこの枠組みから倫理的権原を導かない。その役割は、病院が規制者・保険制度に対して負う診療報酬上の義務と、患者個人に向けられた義務が異なる規範関係であることを明確にする点にある。後者が法的に執行可能な請求となるかは、該当する法源による。

Feinbergのclaiming論はさらに、ある利益が保護されることと、その利益の主体が「自分に対して何かが負われている」と主張できることは同一ではないと示す (Feinberg 1970)。実務上、患者または適切な支援者は、なぜアクセスが制限されるのか、何が制限されるのか、どのくらい続くのか、どのような例外やより制限的でない代替策が検討されたのか、どのように再検討を求められるのかを質問できるべきである。

その保障は、訴訟を必要とせず利用できるべきである。理解可能な説明、明確なreview時点、例外申請ルート、適時の再検討—遅延によりreviewの意味が失われる場合には迅速な再検討—で足りる。

制度上の順序は、倫理的権原→患者向け手続→監督→必要に応じた法的・行政的バックストップ→診療報酬による記録・監査・実装支援である。法律も支払いも、倫理的権原の道徳的源泉ではない。

5. 制度的対照: 患者向け保障は実装可能か

日本の医療法制内にも国外にも、関連する制度形式は既に存在する。本稿はそれらを、法的同等性や優れたアウトカムの証明ではなく、制度的実行可能性を示すために用いる。

5.1 日本の精神保健法制

一般入院医療について、すべての入院患者を一般的な面会権の主体と明示し、原則アクセス、許容される制限、理由、専用のreview経路まで包括的に定める法的枠組みを、本稿では確認できていない。ただし、日本法が契約、人格的利益、自己決定、不法行為その他の法源を通じて何の保護も与えていないという意味ではない。

精神保健法制はそれでも重要な国内対照である。施設だけでなく精神科入院患者を規範の明示的主体とし、制度的制限を受けやすい患者群について、処遇基準は通信・面会が医療上も人権上も重要であり、原則として自由に行われるべきものとする (Ministry of Health, Labour and Welfare 1988; Japan 1950)。制限は、患者の医療または保護に不可欠な範囲に限られ、合理的な理由、合理的方法と範囲、個々の患者の必要性についての慎重な判断を要する。処遇基準は、制限とその理由の記録・説明も扱っている (Ministry of Health, Labour and Welfare 1988)。

さらに精神保健法制は、患者または一定の家族等が退院または処遇改善を求める正式な経路を設け、都道府県知事はこれを精神医療審査会の審査に付さなければならない (Japan 1950; Ministry of Health, Labour and Welfare 2023)。これは一般的な処遇改善reviewの経路であり、面会に特化した法定不服申立てではない。reviewの制度設計は客観性と独立性の確保を意図するが、制度設計がそのまま実効性や一貫して迅速な審査を証明するわけではない。本稿は全国的な運用差を評価しない。

この比較は制度移植ではなく構造の比較である。日本の医療法制内部だけを見ても、患者向け規範は、施設権限、個別化された制限、理由記録、formal reviewと両立し得る。したがって非対称性は同一医療制度の内部にある。精神科入院患者には通信・面会について明示的な患者向け保障が存在する一方、一般入院患者には同等の包括的保障がない。

5.2 クロアチア、ハンガリー、米国

クロアチア患者権利保護法26条は、入院患者が医療機関の院内規則に従って訪問者を受ける権利と、特定の者の訪問を拒否する権利を認める (Republic of Croatia 2004)。これは、関係的アクセスを患者中心に捉える制度例であり、患者が会いたい人を受け入れることと、会いたくない人を排除することの双方を含む。

ハンガリー保健法 Act CLIV of 1997 も、入院患者が他者との連絡を維持し、訪問者を受け、特定の者を排除する権利を認めつつ、病院運営、他患者の権利、診療の継続を考慮した制度運用を許容している (Hungary 1997)。これらは、法定の患者向け保障が無制限アクセスを意味しないことを示す。

米国では、42 C.F.R. §482.13が参加病院に書面の面会権方針を求め、臨床的に必要または合理的な制限を許容しつつ、患者による訪問者選択、同意撤回、拒否を、より広い患者権利・grievance枠組みの中で保障している (United States 2026)。

米国では連邦の面会権規則が2011年から施行されていたが、COVID-19期には病院が制限的な面会方針を採用した (Centers for Medicare & Medicaid Services 2010; Iness et al. 2022)。連邦枠組み自体が臨床的に必要または合理的な制限を認めているため、制限的方針の存在だけで規則違反だったとはいえない。ここから導くべき狭い教訓は、面会権を形式的に認めても、制限の正当化、説明、review、実装をどう行うかという問題は残るということである。

表1 面会保障に関する制度モデルの機能比較

モデル	主体／原則	制限構造	患者向け手続／review	執行
一般入院医療の一般規定 (日本)	施設への期待。面会規定の策定等が推奨される	感染対策等の正当な理由	患者個人向けの理由提示・再検討経路は明示されない	一般入院医療の施設基準・行政上の期待
入退院支援加算1～3 (日本)	病院は正当な理由なく面会を妨げてはならない	やむを得ない制限を必要以上に厳格にしない。書面規定、定期的見直し、掲示	専用の患者個人向け再検討・救済経路は明示されない	届出、診療報酬、調査・指導
精神保健法制 (日本)	精神科入院患者。通信・面会は原則自由	医療・保護に不可欠な範囲。合理的理由・方法・範囲、個別判断	理由の記録・説明。処遇改善review経路 (面会専用ではない)	法令、処遇基準、行政review
クロアチア／ハンガリー	一般入院患者の面会・連絡権	施設運営、他患者の権利、診療上の必要により制限可能	患者を明示的な権利主体とし、特定訪問者を拒否可能	法定患者権利枠組み
米国 42 C.F.R. §482.13	患者の面会権、訪問者選択	臨床的に必要または合理的な制限。書面方針	より広い患者権利・grievance枠組み	Medicare参加条件
提案する多層モデル	関係的アクセスへの推定的倫理的権原	必要性、比例性、個別例外、時間的限定、review可能性	理由、迅速再検討、外部review／相談	施設監督＋必要に応じた法的・行政的バックストップ＋診療報酬による実装支援

6. 感染対策と時間的な正当化負担

関係的アクセスへの推定的な倫理的権原は、感染対策上の裁量を消滅させるものではない。新興感染症、院内アウトブレイク、脆弱性の高い患者の保護では、大きな不確実性のもとで迅速な判断が必要となり得る。すべてのリスクや介入効果が厳密に定量化される前に、暫定的な制限が正当化される場合はある。

しかし感染リスクが存在すること自体は、特定の制限の正当化を自動的に決めない。比較すべきなのは、その制限による追加的な期待利益と、より制限的でない代替策、ならびに制限が課す害である。

面会制限は単なる不作為ではなく、積極的介入である。報告されている影響には、心理的苦痛、コミュニケーションと意思決定の阻害、caregiver participationの低下、一部の状況での栄養摂取低下が含まれる(Hugelius, Harada, and Marutani 2021; Iness et al. 2022)。感染関連利益だけを数え、こうした予見可能な害を除外する正当化は倫理的に不完全である。

したがって、擁護可能な制限は、対象リスク、追加的な期待利益、利用可能な代替策、予見可能な害、範囲、期間、緩和・終了基準を扱うべきである。より制限的でない代替策には、症状スクリーニング、マスク、換気、物理的距離、時間・人数を限定した面会などがあり得るが、何が十分かは病原体と状況に依存する。

日本では次の制度的段階として、trigger indicator、追加的な期待利益、検討した代替策、患者への害、緩和・終了基準を、2026年面会枠組みの下で標準的な記録・説明項目とすることが考えられる。

COVID-19期のvisitor policyに関する証拠は、「制限は一樣に有効だった」あるいは「一樣に無効だった」という単純な命題を支持しない。研究は、施設、患者集団、方針設計、病原体、研究デザインが異質であり、本稿は単一の因果効果を推定するためではなく、文脈依存性と不確実性を示すために用いる。Inessらの系統的レビューは26研究を含み、COVID-19期の文献ではvisitor policyの効果を評価する無作為化試験はなく、COVID-19伝播への効果は十分に研究されておらず、一律方針は患者・訪問者・医療従事者の異質なニーズに対応できないとされた(Iness et al. 2022)。

観察研究では、面会制限と一部の医療関連呼吸器ウイルス感染低下との関連が報告された(Forkpa et al. 2020; Wee et al. 2021)。一方、ある三次病院の感染予防バンドルでは、面会制限を段階的に緩和しても医療関連呼吸器ウイルス感染の再増加は認められず、面会制限単独の寄与は不確実だった(Wee et al. 2021)。また、より柔軟な面会を扱った特定の研究では、感染率の上昇を示さずに患者・家族側の利益が報告されている(Nguyen et al. 2023; Rosa et al. 2019; Fumagalli et al. 2006; Nassar Junior et al. 2018)。

この不確実性は、制限が無効だったことを意味しない。意味するのは、強い制限の純利益を前提として扱うべきではないということである。

緊急時には、不確実性は予防的行動を正当化し得る。同時に、その行動を暫定的なものとし、再評価の対象にすべき理由にもなる。正当化負担はアクセスを求める患者ではなく、制限を課す施設側にある。施設は、制限しなければ必ず感染が起きることを確実に証明する必要はないが、なぜその程度の制限が、代替策や害と比較して十分な追加的利益をもたらすと期待されるのか、比例的に説明する必要がある。

6.1 時間的な正当化負担

緊急事態の開始時に十分だった正当化が、同じ制限を継続する際にも十分であり続けるとは限らない。初期判断は合理的に迅速化され得るが、時間の経過とともに、証拠、代替策、蓄積する害、個別化の可能性が明らかになる。

本稿は、この変化する正当化要求を「時間的な正当化負担(temporal burden of justification)」と呼ぶ。これは本稿の規範的統合であり、確立したドクトリンではない。

この概念は、感染リスクが時間とともに必ず低下すると、制限が必ず緩和されなければならないとも仮定しない。主張は、継続の正当化が、導入後に得られた知見—利用可能な証拠、より制限的でない代替策、蓄積した害、影響を受ける集団、期間、緩和・終了基準—を次第に取り込まなければならないということである。

既存の倫理指針はすでに、比例性、継続的なrisk-benefit再評価、個別例外、必要な間だけ制限を継続することを支持している(World Medical Association 2023; McDougall et al. 2023; Dugdale et al. 2023)。時間的な正当

化負担はこれらを制度的主張へ展開する。緊急措置が長期化するほど、継続する制限に課される証拠上・手続上の要求は高まるべきである。

したがって、開始と継続が同じ負担を負う必要はない。初期には迅速な予防措置が正当化され得る一方、長期継続には通常、より十分な新たな正当化が必要となる。不確実性は予防措置を正当化し得る。しかし、それだけで無期限の継続を正当化することはできない。

7. 定期的見直しと「管理された恒久化」

より強い加算固有基準の対象病院では、2026年改定は面会規定の定期的見直しを要求する(Ministry of Health, Labour and Welfare 2026a)。これは重要だが、reviewは終了・更新を中心とするガバナンスと同一ではない。

終了日、終了基準、明示的な更新決定がなければ、制限は何度reviewされても、実務上は継続がデフォルトであり続けることがある。

本稿はこの状態を「管理された恒久化(managed permanence)」と呼ぶ。これは確立した法的ドクトリンではなく、本稿の分析ラベルである。形式的なreviewは存在するが、制度構造が終了の推定を作らず継続を管理するため、制限が事実上持続する状況を指す。先行研究は、比例的な正当化を超えて残存する制限と明示的sunset mechanismの必要性を論じた(Kujo 2026)。本稿は中でも、formal reviewは存在するが継続が運用上のデフォルトになるという、より狭い設計問題を扱う。

対象は全国の診療報酬規則そのものではなく、病院が実際に課す具体的な制限措置である。

sunset mechanismは、追加措置がなければいつ終了するかを定めることでデフォルトを変え得る(Ranchordás 2014)。本稿が提案する「更新時の新たな正当化」は独自の規範的設計要件であり、sunset clause一般の定義的要素だと主張するものではない。

終了・更新型の構造は、感染リスクが消滅する正確な日を予測する必要はない。初回review日、再評価する指標、緩和・終了基準、早期再検討を発動する条件、更新時に必要な理由、患者・支援者が例外的reviewを求める経路を定めることができる。

目的は自動的な規制解除ではない。正当化できる制限は継続し得るが、その継続は、過去の緊急判断が自己持続する結果ではなく、新たな正当化の結果であるべきである。

8. 制度設計: 倫理的権原から持続的保障へ

承認—制度化ギャップを埋めるには、重要な他者へのアクセスを制限されたとき、患者が何を期待できるかから制度設計を始める必要がある。関係的アクセスが診療報酬や法令による創設に倫理的に先行するなら、その期待は算定状況に依存すべきではない。

本稿は五層の保障を提案する。

第一は倫理的権原である。正当化された制限を認めつつ、関係的アクセスを原則とする。

第二は患者向け手続である。アクセスが制限された場合、患者は、制限の範囲、主要理由、開始時点、予定されるreview、緩和・終了に関係する基準、例外、再検討ルートについて理解可能な情報を受けるべきである。機微な感染対策情報や他患者のプライバシーを開示する必要はないが、「感染対策のため」という一般論だけでは個別化された正当化にならない。少なくとも意思決定記録には、期待される追加的利益、比較した代替策、患者への主要な害を記載すべきである。

再検討は適時でなければならず、時間依存性が高い事例では短い回答期限が必要である。終末期、出産、急変、小児、重大な意思疎通障害では、遅れたreviewが実質的に無意味になり得る。再評価には、制限を課した部署だけでなく、臨床、感染対策、患者支援の視点を含めるべきである。この手続は倫理的義務を運用可能にするものであり、法制化の有無にかかわらず導入できる。

第三は制度的監督である。院内reviewは反復する問題や不一致を検出し得る。内部解決に失敗した場合には、制限方針とreviewの透明性ととともに、外部reviewまたは相談経路を用意できる。日本の医療安全支援セン

ターは、相談、助言、情報提供、連絡調整の既存インフラを提供している (Ministry of Health, Labour and Welfare 2026b; Japan 1948)。現状では面会紛争を拘束的に裁定する機関ではないが、比例性のガイダンス、緊急事例を定められた回答期間付きで病院に照会する機能、結果記録、反復する苦情の集約といった専門的機能を支援し得る。病院の法的回答義務、法定回答期限、是正命令権を付与する場合には、適切な法的・行政的根拠が必要である。

第四は、倫理的・専門的自己規律だけでは不十分な場合の法的または行政的バックストップである。法律が基礎となる利益を作る必要はない。保障をより持続的、可視的、review可能にし、裁量拡大時の侵食に強くする役割を果たし得る。

法形式はあらかじめ一つに決める必要はない。広範な患者権利法制、医療関連法、下位規則、行政基準、その組合せなどが考えられる。保障を狭義の「面会権」だけに閉じ込める必要もなく、尊厳、患者が選ぶ関係のアクセス、正当化された制限、理由提示、比例性、review、緊急時例外という一般原則の方が将来の危機に強い可能性がある。

第五は診療報酬による実装支援である。支払いは、記録、組織プロセス、監査、遵守を支援できるが、患者向け最低保障は特定加算の算定に依存すべきではない。診療報酬監査は、規定の存在だけでなく、review日、終了基準、再検討ルート、回答記録など、患者向け機能が実装されているかを、臨床判断の実質に過度に介入せず確認し得る。

支払いはレバーであって、患者の請求の道徳的源泉ではない。

また、外的な制度遵守と内部の倫理的統治は区別しなければならない。必要書類を作成し定期reviewを行うだけで、日常の制度判断が関係的自律、与益、無危害、尊厳によって導かれていることは証明されない。他方、倫理的コミットメントだけで手続と監督を欠けば脆弱になり得る。本稿は病院の倫理文化を測定するものではなく、この区別は手続遵守と実質的倫理統治が関連しつつ同一ではないことを示すためにのみ用いる。

9. 反論と限界

第一の実務的反論は、診療報酬によってアクセスが改善するなら、保障の形式は重要でないというものである。平均的なアクセス改善は重要な成果である。しかし、平均的改善と、争いのある個別事例での保障は別問題である。制度全体として面会が緩和されても、患者が理由を受け取れず、例外を求められず、適時の再検討にアクセスできないことはあり得る。患者向け保障が最も重要になるのは、施設の選好と患者個人の関係的利益が衝突するときである。

第二の反論は、診療報酬こそ日本で最も現実的な政策手段だというものである。本稿も大部分で同意する。診療報酬は全国的到達範囲を持ち、記録、組織プロセス、質改善を動かし得る。しかし、尊厳や関係的利益を倫理的権原として創設するものではなく、病院は算定状況にかかわらず制限を倫理的に正当化する負担を負う。したがって診療報酬は患者向け保障の代替ではなく、その上に重ねるのが適切である。

第三の反論は、感染対策では迅速な裁量が必要だというものである。本稿も同意する。緊急対応の前に完全な審査を要求してはいない。信頼できるリスクが予防措置を必要とする場合、初期制限は迅速に導入され得る。重要なのは、緊急裁量を無期限の裁量にしないことである。裁量の必要性は、害を無視したり、感染リスクだけを理由に制限を更新したりすることを正当化しない。早期review、例外ルート、時間とともにより十分になる正当化によって、迅速な行動を維持しつつ制度慣性に対処できる。

第四の反論は、精神科医療と国外法制の異質性である。精神科入院医療は独自性があり、クロアチア、ハンガリー、米国、日本は法構造、財政、制度運用が異なる。したがって本稿は機能比較に限定する。それらは、施設権限、合理的制限、患者選択、grievance手続、formal reviewが併存し得ることを示すが、移植すべき完成モデルを示すものではない。

また、米国例は、面会権の形式的保障と緊急時の制限的方針が併存し得ることを示す。枠組み自体が臨床的に必要または合理的な制限を許容するからである。したがって教訓は「規則が破られた」ということではなく、形式的保障だけでは争いのある事例における制限、review、実装の方法は決まらないということである。

経験的・法的限界も残る。本稿は、2026年改定が実際の面会、感染アウトカム、患者経験、遵守に与えた効果を測定していない。加算届出は制度的カバレッジのみを測る。病院数ベースの指標は入院数や入院患者日数で重み付けしておらず、大病院でカバレッジが高いため、患者ベースの到達範囲は54.8%と大きく異なる可能性がある。分子と分母の測定時期はわずかに異なり、施設分類も資料間で完全には一致しないが、導出病院総数と公式病院数は近接していた。

病床規模差は因果的ではない。対象加算には所定の看護職・社会福祉職配置要件があるが、病院レベルの人員配置その他の資源変数は測定していない。

感染対策効果について新たな系統的レビューも実施していない。既存証拠は、利益と害が文脈依存であり、強い制限の純利益を前提として扱うべきでないことを示すためにのみ用いている。

また、日本法上、面会に関連する利益を保護し得るすべての法源を網羅的に特定していない。本稿の倫理的主張は、その不存在を証明することには依存しない。

「管理された恒久化」と「時間的な正当化負担」は、いずれも本稿の文脈を超えた追加検証が必要である。

最後に、関係的アクセスは患者中心である。重要な相手は家族とは限らず、虐待、強制、プライバシー上の懸念、望まれない同席がある場合には、患者による拒否と安全が優先される。

10. 結論

日本の2026年度診療報酬改定は重要な前進である。面会を全国的枠組みに位置づけ、特定の入退院支援加算を届け出る病院に対して、正当な理由のない妨害、制限の強度、書面規定、周知、reviewについてより強い要件を導入した。

しかし、この改定が関係的アクセスの倫理的基礎を作ったわけではない。その患者利益は、尊厳、関係的自律、与益、無危害に由来し、診療報酬上の地位や法的承認に先行する。

より強い加算固有規定は7,949病院中4,358病院(54.8%)をカバーしており、支払い制度に結び付く規則を普遍的な患者向け最低保障とすることの到達範囲の限界を示す。

国内外の比較は、正当化された制限と患者向け保障を制度的に両立させることが可能であると示す。

より大きな課題は、承認—制度化ギャップを制度翻訳によって埋めることである。すなわち、倫理的権原を患者向け手続、監督、必要に応じた法的・行政的バックストップ、診療報酬による実装支援へ変換することである。

緊急時の不確実性は予防的制限を正当化し得るが、制限が長期化するほど、施設は、証拠、代替策、害、範囲、期間、更新・終了条件をより十分に説明する負担を負うべきである。

定期的reviewだけでは継続をデフォルトから外せない。終了日または終了基準、明示的な更新決定、更新時の理由記録を設けることで、面会ガバナンスを「管理された恒久化」から終了・更新型reviewへ移すことができる。

診療報酬は実装のレバーであって、患者の請求の道徳的源泉ではない。生命倫理上の課題は関係的利益を認識するだけでなく、緊急時に裁量が最も拡大するときにも、それを保持できる制度を構築することである。

謝辞・AI利用開示

2026年の原稿作成過程で、著者らはChatGPT (OpenAI) およびClaude (Anthropic) を、原稿構成、言語調整、敵対的批評、出典確認ワークフローに使用した。AI支援を受けた内容と出典はすべて人間の著者が独立に確認した。研究問い、規範的議論、分析、結論、最終文言は人間の管理下に置かれ、著者らが本稿について全面的な責任を負う。

Online Resource 1: 制度的カバレッジ分析のための一次資料マニフェスト、日本語一次資料の対訳表、データソース。

参考文献

Asagumo, A. 2022. Relational autonomy, the right to reject treatment, and advance directives in Japan. *Asian Bioethics Review* 14(1): 57–69. <https://doi.org/10.1007/s41649-021-00191-1>.

- Centers for Medicare & Medicaid Services. 2010. Medicare and Medicaid Programs: Changes to the Hospital and Critical Access Hospital Conditions of Participation To Ensure Visitation Rights for All Patients. Final rule. 75 Fed. Reg. 70831 (November 19, 2010), effective January 18, 2011. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-11-19/pdf/2010-29194.pdf>. Accessed September 10, 2026.
- Dugdale, L.S., K.L. Esbensen, L. Snyder Sulmasy, and the ACP Ethics, Professionalism and Human Rights Committee. 2023. Ethical guidance on family caregiving, support, and visitation in hospitals and residential health care facilities, including during public health emergencies: An American College of Physicians position paper. *Journal of General Internal Medicine* 38(8): 1986–1993. <https://doi.org/10.1007/s11606-023-08070-1>.
- Feinberg, J. 1970. The nature and value of rights. *Journal of Value Inquiry* 4(4): 243–257. <https://doi.org/10.1007/BF00137935>.
- Forkpa, H., A.H. Rupp, S.T. Shulman, S.J. Patel, E.L. Gray, X. Zheng, M. Bovee, and L.K. Kociolek. 2020. Association between children’s hospital visitor restrictions and healthcare-associated viral respiratory infections: A quasi-experimental study. *Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society* 9(2): 240–243. <https://doi.org/10.1093/jpids/piz023>.
- Fumagalli, S., L. Boncinelli, A. Lo Nostro, et al. 2006. Reduced cardiocirculatory complications with unrestrictive visiting policy in an intensive care unit: Results from a pilot, randomized trial. *Circulation* 113(7): 946–952. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.105.572537>.
- Høeg, T.B., J. Knudsen, and V. Prasad. 2025. Lessons from COVID-19 patient visitation restrictions: six considerations to help develop ethical patient visitor policies. *Monash Bioethics Review* 43(2): 289–300. <https://doi.org/10.1007/s40592-025-00230-9>.
- Hohfeld, W.N. 1913. Some fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning. *Yale Law Journal* 23(1): 16–59. <https://doi.org/10.2307/785533>.
- Hugelius, K., N. Harada, and M. Marutani. 2021. Consequences of visiting restrictions during the COVID-19 pandemic: An integrative review. *International Journal of Nursing Studies* 121: 104000. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104000>.
- Hungary. 1997. Act CLIV of 1997 on Health, section 11 (Right to maintain contact). Nemzeti Jogszabálytár. <https://njt.hu/jogszabaly/1997-154-00-00>. Accessed September 7, 2026.
- Iness, A.N., J.O. Abaricia, W. Sawadogo, et al. 2022. The effect of hospital visitor policies on patients, their visitors, and health care providers during the COVID-19 pandemic: A systematic review. *American Journal of Medicine* 135(10): 1158–1167.e3. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2022.04.005>.
- Japan. 1948. Medical Care Act (Act No. 205 of 1948), art. 6-13. e-Gov Law Search. <https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205>. Accessed September 7, 2026.
- Japan. 1950. Act on Mental Health and Welfare for Persons with Mental Disorders (Act No. 123 of 1950), arts. 36–38-5. e-Gov Law Search. <https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000123>. Accessed September 7, 2026.
- Kujo, G. 2026. Visitor restrictions beyond the emergency phase: lessons from Japan for proportionality and sunset mechanisms. *Journal of Medical Ethics*. Advance online publication, March 10, 2026. <https://doi.org/10.1136/jme-2026-111889>.
- McDougall, R., C. Warton, C. Chew, C. Delany, D. Ko, and J. Massie. 2023. Visitor restrictions in hospitals during infectious disease outbreaks: An ethical approach to policy development and requests for exemptions. *Bioethics* 37(7): 715–724. <https://doi.org/10.1111/bioe.13188>.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. n.d. Response following the reclassification of COVID-19 as a Category 5 infectious disease [in Japanese]. <https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html>. Accessed September 17, 2026.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. 1988. Standards prescribed by the Minister of Health and Welfare pursuant to Article 37(1) of the Act on Mental Health and Welfare for Persons with Mental Disorders (Ministry of Health and Welfare Notification No. 130, April 8, 1988), provisions on communication and visitation. https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1. Accessed September 7, 2026.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. 2023. Psychiatric Review Board Operational Manual, as revised by Notification No. 1127-5 of November 27, 2023 (effective April 1, 2024). Current full manual: <https://www.mhlw.go.jp/content/001501540.pdf>; revision notice: <https://www.mhlw.go.jp/content/001172523.pdf>. Accessed September 7, 2026.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. 2025. Inpatient and outpatient medical care: Materials for the Survey and Evaluation Subcommittee, August 28, 2025, p. 68, Rules for visitation [in Japanese; reporting the fiscal year 2024 survey]. <https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001551150.pdf>. Accessed September 17, 2026.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. 2026a. Handling of procedures concerning facility standards for basic medical fees and related notifications (Insurance Medical Affairs Notification No. 0305-7, March 5, 2026, corrected version), including provisions

- on visitation and Discharge Support Add-ons 1–3. <https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732097.pdf>. Accessed September 7, 2026.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. 2026b. Medical Safety Support Centre Operational Guidelines, revised March 31, 2026. <https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001685657.pdf>. Accessed September 7, 2026.
- Ministry of Health, Labour and Welfare. 2026c. Dynamic Survey of Medical Institutions: Preliminary figures as of the end of May 2026. <https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/iryosd/m26/dl/is2605.pdf>. Accessed September 7, 2026.
- Morikawa, I. 1994. Patients' rights in Japan: Progress and resistance. *Kennedy Institute of Ethics Journal* 4(4): 337–343. <https://doi.org/10.1353/ken.0.0154>.
- Nassar Junior, A.P., B.A.M.P. Besen, C.C. Robinson, M. Falavigna, C. Teixeira, and R.G. Rosa. 2018. Flexible versus restrictive visiting policies in ICUs: A systematic review and meta-analysis. *Critical Care Medicine* 46(7): 1175–1180. <https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000003155>.
- Nguyen, C., R. Lampen, A. Grooms, et al. 2023. Impact of an inclusive COVID-19 visitation policy on patient satisfaction and visitor safety. *American Journal of Infection Control* 51(8): 900–906. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2022.11.020>.
- Ranchordás, S. 2014. *Constitutional Sunsets and Experimental Legislation: A Comparative Perspective*. Cheltenham: Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781783478958>.
- Regional Bureaus of Health and Welfare. 2026. Lists of accepted facility-standard notifications for medical institutions, current as of July 1 or August 1, 2026. Hokkaido, Tohoku, Kanto-Shinetsu, Tokai-Hokuriku, Kinki, Chugoku-Shikoku, and Kyushu Regional Bureaus of Health and Welfare, and the Shikoku Branch Office. Official access pages and analytical snapshot dates are recorded in Online Resource 1. Accessed September 25, 2026.
- Republic of Croatia. 2004. Act on the Protection of Patients' Rights (*Zakon o zaštiti prava pacijenata*), art. 26 (Right to maintain personal contacts). *Narodne novine* 169/2004. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2004_12_169_2953.html. Accessed September 7, 2026.
- Rosa, R.G., M. Falavigna, D.B. da Silva, et al. 2019. Effect of flexible family visitation on delirium among patients in the intensive care unit: The ICU Visits randomized clinical trial. *JAMA* 322(3): 216–228. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.8766>.
- United States. 2026. 42 C.F.R. §482.13, Condition of participation: Patient's rights, including patient visitation rights. Electronic Code of Federal Regulations. <https://www.ecfr.gov/current/title-42/chapter-IV/subchapter-G/part-482/subpart-B/section-482.13>. Accessed September 7, 2026.
- Wee, L.E., E.P. Conceicao, J.X.Y. Sim, M.K. Aung, and I. Venkatachalam. 2021. The impact of visitor restrictions on health care-associated respiratory viral infections during the COVID-19 pandemic: Experience of a tertiary hospital in Singapore. *American Journal of Infection Control* 49(1): 134–135. <https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.11.006>.
- World Medical Association. 2023. WMA statement on medical ethics during public health emergencies. Adopted October 2023. <https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-medical-ethics-during-public-health-emergencies/>. Accessed September 7, 2026.